



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : انتسال فام مري بشاي =

المحافظة : الجيزة الحى / المدينة : بولاق الدكرور العنوان : =

رقم البطاقة : 27401142503286 رقم التليفون : 01201512997 تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 14-01-1974 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض

بالصبغة [11127]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: انتسال فام مري بشاي =
National ID: 27401142503286



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



Dms
هرمون فيمارا

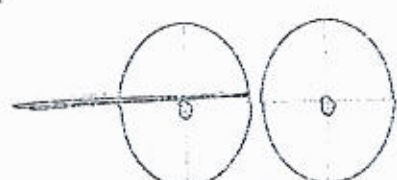


مبادرة رئيس الجمهورية
لصحة المرأة المصرية

الهيئة العامة
للتنظيم
الأسري
والعائلي

MDT FORM

19/3/2022

Name	انتال عام سرى	MRN	0552 C.C.I
Age	47	ID	15.101599v
Menopausal status		Phone	011120297
OCP		marital status	—
Comorbidity	Med → HTN, Thyroid Surg → Rm	Family history	- No FH
Clinical Data			
Bx:	R		
ER: +ve 8/8	PR: +ve 8/8	HER 2: -ve	KI67: 10-15%
Sonomammography:			
Post RT MRM.			
Mets Workup: IDC II LUN Rna 0117			
Recommendations:	(PT2N0) free margin		

MDT OUTCOME & PLAN

19/3/2022 → - No need for PORT (MRM, PT2N0)
- Adjuvant (4C) TC (Lamivel A, PT2N0)
Perimenopausal
- Then Adjuvant 2ys Tam
Then switch A.I (after confic)

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

19/3/2022



Patient Name : الأسماء / انتسالي قام مري بشاي	Request No. : 13006309
Patient No. : 27401142503286	Request Date : 22/02/2022
Path. No. : 502/2022	Verification Date : 13/03/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer.

Nature of the specimen:

Right MRM.

Gross Examination:

- Procedure: Right MRM specimen measured 23x21x2cm, covering skin piece 21x9cm.
- Tumor extent: An ill-defined greyish white firm mass
- Localization: UIQ
- Size: 2.5x2.3x1cm
- Distance from margins: 3cm away from deep margin.
- Lymph nodes number and size: 7 lymph nodes, up to 2x1cm.
- Additional findings: The adjacent breast tissue was greyish and red, showing slit like spaces and oozing yellowish material.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade 2(differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+2+1)
- Lymph node involvement: All lymph nodes were free (0/17).
- Resection Margins: Free deep margin.
- Free nipple and areola.
- Additional pathologic findings: The surrounding breast tissue showed fibroadenosis.

Diagnosis:

Right MRM:

- Invasive duct carcinoma grade 2.
- All lymph nodes were free (0/17).

Verified by :



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6087

Female :	النوع	انتقال فام مري بشاي	اسم المريض :
القاهرة :	العنوان	47 Y	السن :
29/11/2021 12:46 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة :
06/12/2021 10:43 :	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل :
		مركز اورام دار السلام	عناية :

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by: -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)

PR: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)

HER2/neu protein over expression : NO membrane staining of tumor cells (core biopsy).

Ki67 :positive nuclear staining of 10 - 15 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 3 / 8)

PR: POSITIVE (SCORE 8 / 8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE

#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 10 - 15 % .

Pathologist:

د/تريزا ماهر

Lab Director:

د/ تريزا ماهر

الإدارة المركزية للتحليلات
السريرية



Patient: <u>Enabel Fom Marie</u>	Date: <u>15-12-2021</u>
----------------------------------	-------------------------

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Right breast UOQ irregular speculated mass lesion measuring 2.6 X 2 cm.
- Prominent right axillary level I lymph nodes are seen.
- Few bilateral scattered pulmonary nodules, the largest is noted at lateral segment of middle lung lobe measuring 5 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. Right hepatic lobe segment VIII calcific focus mostly representing post granulomatous sequel.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUCD is seen in place.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.